



תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: דצמבר 2014 מהדורה: תאריך עדכון: יוני 2020
	שם הנוהל: ניהול הריון ולידה בנשאות HIV כותב הנוהל: ד"ר יחיאל בורק, ד"ר אנה פטרוסב		
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב וינר	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	נספחים: נספח 1 –תרשים זרימה לניהול לידה של נשאת HIV
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 7			

תוכן העניינים

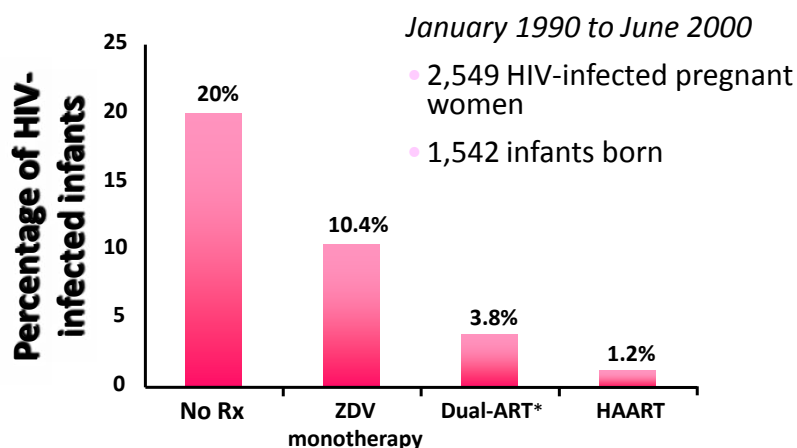
2	מבוא:
2	מטרת הנוהל:
3	קבוצות סיכון:
3	העברה של נגיף HIV
3	המלצות מעקב הריון:
3	בדיקות מיוחדות בהריון:
4	ניהול הלידה:
4	אופן היילוד (ראה נספח 1):
4	הנחיות כלליות לטיפול במהלך לידה נרתיקית:
4	הטיפול התרופתי במהלך הלידה:
5	המלצות לטיפול ומעקב במשך הלידה:
6	נספח 1 – תרשים זרימה לניהול לידה של נשאת HIV
7	סימוכין:

מבוא:

שיעור המקרים החדשים בישראל של HIV בשנת 2015 הוא 48.7 למיליון (לפי נתוני הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה-למ"ס). שיעור זה נמוך מזה הקיים ברוב מדינות מערב אירופה וצפון אמריקה, אך עדיין קיימים פערים גדולים בין תת אוכלוסיות שונות בארץ. הדבקת היילוד מתרחשת בעיקרה במהלך הלידה ולכן אבחון וטיפול במחלת ה-AIDS –או בנשאות HIV בהריון, וטיפול בילוד בשבועות הראשונים לחייו, מפחיתים משמעותית את המעבר הוורטיקלי של הנגיף מ-25% ל-2% ואף פחות (במטופלות ברמב"ם אחוז ההדבקה הוורטיקלית נמוך מ-1%). גם אם האבחון והטיפול נעשים רק בעת הלידה או לאחריה, עדיין ניתן להפחית משמעותית את הסיכון להדבקת היילוד [1].

קיים קשר ישיר בין זיהום נאונטלי לעומס הנגיפי בדם במספר עותקים במ"ל [2].

Vertical Transmission (MTCT) of HIV: Effect of various therapies



* Dual-ART: dual antiretroviral therapy with no or one highly active drug

Cooper et al. *JAIDS* 2002; 29:484–494

מטרת הנוהל:

הגדרת ניהול הריון ולידה עבור נשאות HIV

קבוצות סיכון:

הסיכון העיקרי להדבקה ב HIV הוא כאשר הנשים או בני זוגם משתייכים לאחת או יותר מהקבוצות הבאות:

- מקיימים יחסי מין מזדמנים ללא הגנה
- משתמשים בסמים בהזרקה
- ספקי שירותי מין
- עולים מאזורים אנדמיים לאיידס: כל מדינות אפריקה, אוקראינה, רוסיה, אתיופיה, הודו.
- אנשים שקיימו יחסי מין מזדמנים בעת שביקרו/ גרו באזור אנדמי לאיידס

על פי משרד הבריאות יש להמליץ על בדיקות סקר ל HIV לכלל הנשים ההרות.

אי לכך, יש לוודא לגבי כול יולדת המגיעה לחדר לידה את תוצאות בדיקות ה – HIV אשר עברה ובמידה ולא נבדקה בתחילת ההריון או ממש לפני כניסתה להריון או שקיים ספק האם בוצעה בדיקת HIV יש לשלוח בדיקת HIV במועד קבלתה לחדר לידה.

אם האבחון נעשה לראשונה בחדר הלידה יש ליידע את היולדת כי האבחנה איננה ודאית טרם ביצוע בדיקה נוספת אך עקב זהירות יינתן טיפול תרופתי בלידה כמקובל בנשאות HIV

במקרה של אבחון, הדיווח יועבר למשרד הבריאות באחריות המעבדה/מרפאת איידס (ולא ע"י מחלקת יולדות).

טיפול תרופתי מומלץ לכל הנשים ההרות הנשאות, ללא תלות בעומס הנגיפי או בספירת תאי ה CD4 לצורך הפחתת המעבר הוורטיקלי. [1]

העברה של נגיף HIV

- יחסי מין
- מוצרי דם נגועים
- העברה ורטיקלית
- הנקה

המלצות מעקב ההריון

מומלץ שמעקב ההריון יתבצע ע"י צוות הכולל רופא ממרפאת האיידס והמרפאה לרפואת האם והעובר [1,2]

בדיקות מיוחדות בהריון

בנוסף לבדיקות הרטינה שמבוצעות בכל אישה הרה מומלץ לבצע בדיקות נוספות (באחריות מרפאת איידס):

- ספירת דם בעת בדיקות דם לרמת CD 4 ועומס נגיפי, כל 3 חודשים או לאחר שינויים בטיפול.
- מומלץ להשלים בדיקות סרולוגיה ל: הפטיטיס B, הפטיטיס C, טוקסופלזמוזיס, סיפיליס, וארצילה, CMV תבחין לשחפת, משטח פאפס לפי הצורך.

- בדיקות נוספות מומלצות: תפקודי כבד, תפקודי כליה, כימיה.
- מומלץ לחסן במהלך ההריון נשים שאינן מחוסנות נגד שפעת ושעלת. [1,3] חיסון שעלת מומלץ בכל הריון וחיסון שפעת בעונה ללא קשר לסטטוס חיסוני בעבר לכל אשה הרה.
- טיפול תרופתי במהלך ההריון יינתן על ידי רופאי מרפאת האיידס.

ניהול הלידה

- מרבית מקרי ההדבקה לילוד מתרחשים בשליש האחרון של ההריון ועיקרם בלידה עצמה, ולכן רצוי לתכנן בצורה מיטבית את אופן היילוד, ואת הטיפול באם.
- יש ליידע רופא ילודים בכל לידה של הרה נשאית. [1]
- יש לתעד בכל קבלת יולדת בקבוצת סיכון סטטוס HIV ו HBS. אם לא ידוע יש לקחת בדיקה דחופה ולתעד. זאת בשל ההשלכות המיידיות על הטיפול בילוד בשעותיו הראשונות.

אופן היילוד (ראה נספח 1)

- משך ירידת מים בלידה אינו משפיע על המעבר הוורטיקלי. [1]
- לנשים עם עומס נגיפי מעל 1000 עותקים למ"ל בשלושה חודשים אחרונים לפני הלידה יש לתכנן ניתוח קיסרי לשבוע 38 להריון [1,2,4]
- בנשים אשר בהן לא ידוע העומס הנגיפי בשלושה חודשים אחרונים לפני הלידה ובכל מקרה לא ברור יש להתייעץ עם מרפאת האיידס לגבי אופן היילוד

הנחיות כלליות לטיפול במהלך לידה נרתיקית

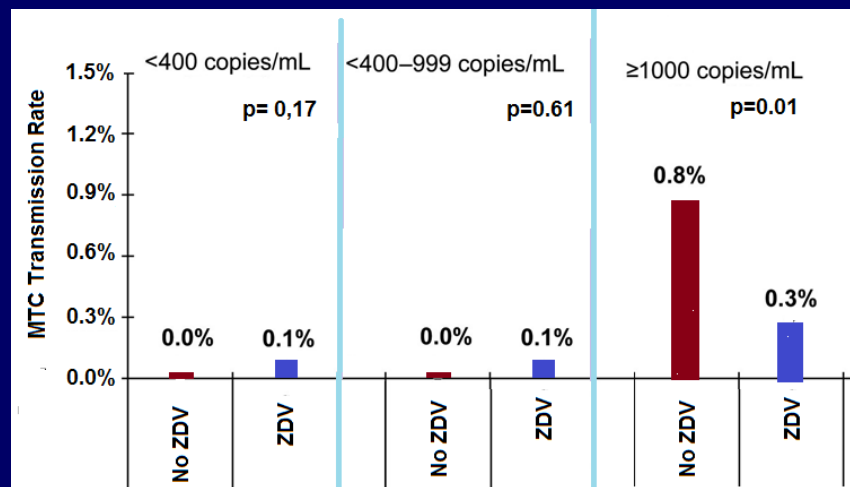
- מומלץ להימנע מניטור פנימי
- בנשאות HIV מטופלות במעכבי הפרוטאז אין להשתמש במטרגין (שילוב של מעכבי הפרוטאז ומטרגין עלול לגרום לווזקונסטריקציה חמורה). [1]

הטיפול התרופתי במהלך הלידה

- לנשאות HIV עם עומס ויראלי נמוך מ-1000 עותקים למ"ל באופן עיקבי בשלבים המאוחרים של ההריון וסמוך למועד הלידה, ואשר הענות לטיפול במהלך ההריון היא טובה וללא חשש לעמידות לטיפול המשולב, אין המלצה לטיפול תוך ורידי ב-Zidovudine ולפי מחקרים עדכניים אינו מפחית את הסיכון להעברה מאם לעובר
 - בהרה המיועדת לניתוח קיסרי מתוכנן עקב עומס נגיפי מעל 1000 עותקים למ"ל, יש להתחיל טיפול תוך ורידי ב-Zidovudine שלוש שעות לפני תחילת הניתוח הקיסרי ועד סיומו.
- Zidovudine ניתן תוך ורידי, במינון 2 מ"ג/ק"ג במשך שעה, ובהמשך 1 מ"ג/ק"ג/שעה [1,2]

- נשים המקבלות טיפול אנטי-רטרוויראלי משולב, ימשיכו טיפול זה במהלך הלידה ולפני ניתוח קיסרי, המשך הטיפול מעניק הגנה מקסימלית לאם וליילוד ומפחיתים את הסיכון ליצירת עמידות עקב החסרת מנה.

Mother-to-child transmission (MTCT) rates of HIV among HIV-1 infected women receiving ART during pregnancy, by use of IV zidovudine (ZDV), according to level of HIV RNA at delivery

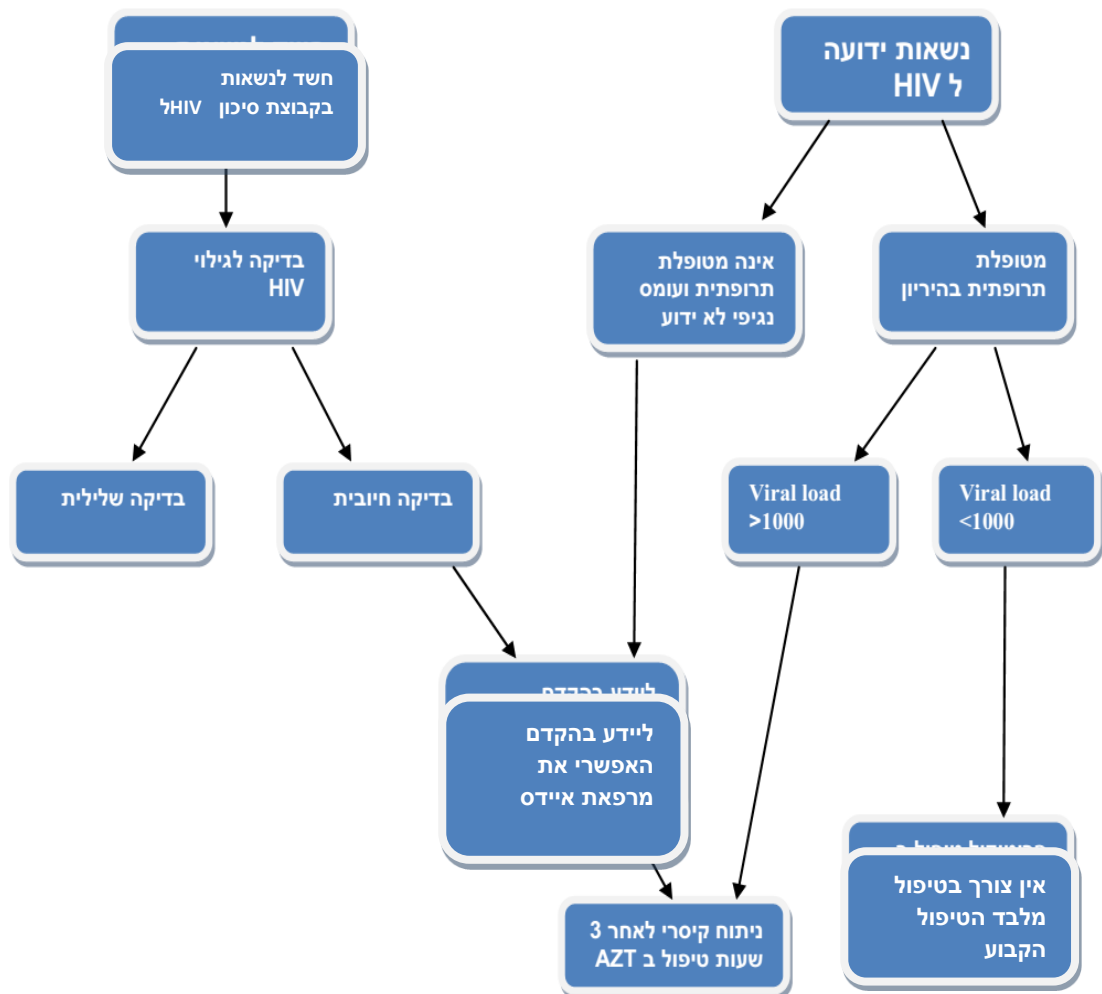


Briand N et al. *Clin Infect Dis* 2013; 57:903-914

המלצות לטיפול ומעקב במשכב הלידה

- יש להימנע מהנקה
- ההחלטה לגבי המשך טיפול תרופתי לאחר הלידה תתבצע על פי הנחיות רופא ממרפאת האיידס
- יש להפנות את האם והתינוק למרכז איידס להמשך טיפול ומעקב [1,2]

נספח 1 – תרשים זרימה לניהול לידה של נשאת HIV



נוהל מס': 060.20
שם הנוהל: ניהול הריון ולידה בנשאות HIV
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



מב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

סימוכין:

1. ניהול הריון ולידה בזיהומים מסכני אם ועובר. נייר עמדה. האיגוד הישראלי למיילדות. מאי 2013.
2. Cunningham. F; Williams Obstetrics (24th edition), McGraw-Hill professional, 2014.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists, Committee Opinion. Prenatal and Perinatal Human Immunodeficiency Virus Testing: Expanded Recommendations. No. 418, September 2008, Reaffirmed 2011.
4. American College of Obstetricians and Gynecologists, Committee Opinion. Scheduled Cesarean Delivery and the Prevention of Vertical Transmission of HIV Infection. No. 234, May 2000, Reaffirmed 2010.